Kapitel 13: Hochbegabungsverhalten von pathologischem Verhalten unterscheiden

Mein fünfjähriger Sohn Dave ist hochbegabt und talentiert und seit einem Jahr bei einem Psychologen in Behandlung. Die Therapie soll ihm helfen, besser mit den traumatischen Erfahrungen zurechtzukommen, die er in den vergangenen Jahren gemacht hat: meine Scheidung von seinem Vater, ein schwerer Autounfall, ein Anfall von Borreliose und die Krankheit und der Tod seines Großvaters. In der Vorschule war Dave durch einige Verhaltensprobleme aufgefallen. Immer, wenn es darum ging, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln, war er sehr aufgebracht, weinte und warf sich auf den Boden. Oft war er so sehr in eine Tätigkeit versunken, dass er sie einfach nicht beenden wollte. Bisweilen lehnte er sich auch gegen die Erzieherinnen auf.

Einmal, als die Erzieherin ihm zeigen wollte, wie man seinen Namen schreibt, weigerte er sich, es so zu machen wie sie, und schrieb stattdessen alles in Großbuchstaben. Die Erzieherin wurde wütend und gab Dave dreimal die Gelegenheit, den Namen „richtig" zu schreiben. Beim dritten Mal schrieb er ihn so, wie sie es wollte – aber den letzten Buchstaben drehte er absichtlich auf den Kopf, noch dazu spiegelverkehrt. Als ich ihn später fragte, warum er das gemacht hatte, meinte er, es sei ihm egal, wie man seinen Namen schreibt – Buchstaben schreiben sei „langweilig".

Wahrscheinlich hätte Dave lieber Altgriechisch gelernt oder zwei Stunden lang ein impressionistisches Gemälde gemalt. Er hat eine lebhafte und kreative Fantasie, und manchmal stellt er sich vor, Komponisten wie Johannes Brahms oder Johann Strauss seien seine Freunde. Zu Hause legt er manchmal eine Strauss-CD ein, und dann sitzen wir mucksmäuschenstill auf seinem Bett und hören zu, so, als würde Strauss persönlich ein Konzert für uns geben.

Dave nutzt seine Vorstellungskraft auch, um die Scheidung seiner Eltern zu verarbeiten. Eines Tages nahm er eine imaginäre Babysitterin mit in den Kindergarten und nannte sie wie die neue Freundin meines Exmanns. Er stellte ihr sogar einen Stuhl hin, damit sie an den Aktivitäten teilnehmen konnte. Als die Erzieherin die Kinder wie üblich aufforderte, sich auf den Teppich zu setzen, um ihnen dann eine Geschichte vorzulesen, machte Dave keine Anstalten, sich dazuzusetzen, sondern malte weiter an einem Bild. Der Erzieherin erklärte er, dass seine „böse Babysitterin" ihm verboten hatte, den Anweisungen zu folgen.

Dann stellt er sich vor, er sei ein Komponist aus jener Epoche, der sich gerade eine neue Symphonie ausdenkt, und er vertieft sich so sehr in seine Rolle, dass er Melodien summt – auch in Situationen, in denen das nicht angebracht ist, zum Beispiel, wenn die Erzieherin den Kindern gerade etwas erklärt.

Die Kinderärztin und der Psychologe haben mir gesagt, dass sich das mit der Zeit legen würde und dass man Dave einfach „Zeit lassen" solle. Der Psychologe hat vorgeschlagen, dass die Erzieherinnen ihn vorwarnen, wenn eine neue Aktivität ansteht, damit Dave die Tätigkeit, mit der er gerade beschäftigt ist, zu Ende führen kann. Das soll ihm den Übergang erleichtern. Ich habe auch ein paarmal mit Dave gesprochen und ihm erklärt, dass er aus dem Alter raus sei, in dem man solche Trotzanfälle hat, und dass diese Taktik zu nichts führt.

Ich war schockiert, als mich die Erzieherin und jemand von der Schulbehörde aufforderten, meinen Sohn bei einem Psychiater vorzustellen, und mir rieten, zusammen mit meinem Exmann einen Erziehungskurs zu absolvieren (das hatten wir zu dem Zeitpunkt bereits getan). Die beiden Pädagogen waren der Meinung, Dave habe zwanghafte Neigungen und sei möglicherweise dabei, eine Zwangsstörung zu entwickeln. Sie meinten, Dave dürfe im nächsten Jahr wieder in den Kindergarten kommen – wo ich selbst arbeite –, aber nur, wenn sich sein Verhalten bis zum Ende des Schuljahrs besserte. Ein Facharzt, so hieß es, sei in diesem Fall besser als ein Psychologe, da er gegebenenfalls auch Medikamente verschreiben konnte.

Ich beschloss, eine bessere Lösung für Daves Probleme zu finden als Medikamente. Ich sprach mit dem Psychologen darüber, und er meinte, dass Dave manchmal tatsächlich zwanghaft wirkte, aber auf keinen Fall an einer Zwangsstörung litt. Dennoch war nicht zu übersehen, dass er Verhaltensprobleme hatte. In Absprache mit der Erzieherin begann der Psychologe mit dem BASC (Behavior Assessment System for Children), einer Evaluation, bei der die Erzieherinnen (bei Schulkindern die Lehrer) und die Familienmitglieder, basierend auf ihren Beobachtungen, Fragen über das Kind beantworten sollen. Ich habe auch Dave gefragt, wie er seiner Meinung nach sein Verhalten verbessern könnte, und er schlug ein Verhaltensdiagramm vor. Die Erzieherin unterstützte die Idee. Anfangs verbesserte sich Daves Verhalten mit dieser Methode tatsächlich, aber nach ein paar Wochen fiel er wieder in alte Muster zurück. Dave wollte perfekt sein, und wenn er es nicht schaffte, einen Belohnungsaufkleber für sein Verhaltensdiagramm zu bekommen, rutschte sein Selbstwertgefühl in den Keller.

Da ich aus erster Hand wusste, wie pädagogisch wertvoll die Einrichtung war, die Dave besuchte und in der ich arbeitete, befürchtete ich, dass man ihn im folgenden Schuljahr nicht mehr zulassen würde. Ich war entschlossen, eine Lösung zu finden. Also fing ich an, über Hochbegabtenförderung zu recherchieren, und was ich dabei herausfand, war erstaunlich. Auf der Internetseite familyeducation.com entdeckte

ich das Profil eines hochbegabten jungen Kindes, zu dessen Merkmalen Dinge wie „Perfektionismus", „intensive Reaktionen auf Lärm, Schmerz oder Frustration" und „lebhafte Fantasie" (zum Beispiel imaginäre Freunde) gehörten. Mir war sofort klar, dass ich die Ursache für Daves Verhaltensprobleme gefunden hatte. Ich war erleichtert und zugleich schockiert darüber, dass ich während meiner Ausbildung nie etwas über Hochbegabungsverhalten und Hochbegabtenförderung erfahren hatte. Doch ich erkannte rasch, dass die wenigsten Erzieher, Lehrer und Psychologen darin geschult waren.

Und so begann ich einen Crashkurs in Sachen Hochbegabung. Glücklicherweise stieß ich auf ein sehr wichtiges Buch von James Webb, Elizabeth Meckstroth und Stephanie Tolan: *Hochbegabte Kinder, ihre Eltern, ihre Lehrer. Ein Ratgeber* (deutsche Ausgabe 2007). Als ich dieses Buch zu lesen begann, war ich sehr erleichtert, denn ich entdeckte dort Beschreibungen genau jener Situationen, die auch meinem Sohn Probleme bereiteten. Und was noch wichtiger war: Ich fand Lösungen, die ich auch umsetzen konnte!

Bei der nächsten Sitzung teilte ich Daves Psychologen mit, was ich herausgefunden hatte. Just an jenem Tag lagen auch die Ergebnisse des BASC-Tests vor. Wie sich herausstellte, fiel ein ungewöhnlich großer Anteil von Daves Verhaltensweisen in den Bereich „atypisch". Einige Erzieherinnen hatten geschrieben, dass Dave Dinge sah und hörte, die nicht da waren, und dass er häufig den Bezug zur Realität verlor. Offenbar „interagierte" er so überzeugend mit seinen imaginären Freunden, dass die Erzieherinnen dachten, er würde sie tatsächlich sehen und hören. Doch ich kannte den Unterschied zwischen Halluzinationen und dem Spiel mit imaginären Freunden, denn ich hatte einmal erlebt, wie Dave aufgrund der Nebenwirkung eines Asthma-Medikaments halluzinierte und tatsächlich den Bezug zur Realität verlor, und das war ganz anders als sein Umgang mit den Figuren, die seiner Fantasie entsprangen. Ich fragte mich, wie viele BASC-Ergebnisse missdeutet werden, nur weil die Kinder imaginäre Spielkameraden haben. Ich fragte mich auch, was passiert wäre, wenn man Dave zu einem Psychiater geschickt hätte, der ihn nicht kannte, oder zu einer anderen Fachperson, die sich mit Hochbegabungsverhalten nicht auskannte und der man mitteilte, mein Sohn würde halluzinieren.

Im Anschluss an das Treffen mit dem Psychologen vereinbarte ich einen Termin mit dem Leiter des Kindergartens und seiner Stellvertreterin. Ich brachte meine Bücher und verschiedene Fachartikel mit, die ich bei www.sengifted.org (der Internetseite von Supporting Emotional Needs of the Gifted) heruntergeladen hatte, damit sie einen Einblick in die Thematik bekamen. Ich erklärte ihnen, dass Daves Verhaltensprobleme meiner Ansicht nach direkt auf seine Hochbegabung zurückzuführen waren, und zitierte einige Beispiele aus der Literatur, die das Verhalten meines Sohnes beschrieben. Ich berichtete auch, dass ich begonnen hatte, die Empfehlungen

umzusetzen, die ich in der Literatur gefunden hatte, und dass bereits erste Resultate erkennbar waren. Ich war sehr erleichtert, als der Leiter sagte, das alles würde ihm einleuchten und dass wir Daves Verhaltensprobleme fortan aus dieser Perspektive betrachten sollten. Die stellvertretende Leiterin war ebenfalls für Strategien offen, die meinem Sohn helfen konnten, und sie wollte das Buch von Webb et al., das ich empfohlen hatte, allen Pädagogen in der Einrichtung zugänglich machen. Auch Daves Erzieherin interessierte sich dafür und las das Buch.

Bis zu den großen Ferien und dem Ende des Schuljahrs blieben uns noch acht Wochen Zeit. Daves Verhalten machte Fortschritte, aber seine Trotzanfälle traten jetzt öfter zu Hause auf. Einmal, nachdem ich zufällig gerade gelesen hatte, was man in solchen Fällen tun soll, appellierte ich an seine verständnisvolle Seite, warf mich selbst auf den Boden und fing an zu schreien. Ich fragte ihn, was seine Freunde wohl denken würden, wenn sie ihn so sehen würden. Dave runzelte die Stirn und sagte: „Oh Mommy! Das wäre wirklich schlimm!" Ich erklärte ihm, dass er versuchen müsse, das nicht mehr zu tun, weil es seine Freunde befremden würde. Ich wusste, dass er das verstehen würde. Von da an hatte er nur noch einen einzigen Trotzanfall im Kindergarten – eine enorme Verbesserung!

Was Daves Perfektionismus betraf, so machten seine Erzieherin, sein Psychologe und ich ihm klar, dass niemand perfekt ist. Wenn die Erzieherin oder ich einen Fehler machten, wiesen wir Dave darauf hin. Bei monotonen Aktivitäten wie Buchstaben schreiben erinnerte die Erzieherin ihn daran, dass er etwas tun durfte, was ihm Spaß machte, sobald er die unliebsame Aufgabe beendet hatte. Daraufhin schrieb Dave bereitwillig seine Buchstaben. Wir erklärten ihm, dass er sich nur im „Ich tue so, als ob"-Bereich des Kindergartens wie ein Komponist kleiden durfte; ansonsten wäre das den anderen Kindern gegenüber unfair, da sie sich ja auch nur unter bestimmten Voraussetzungen verkleiden durften. Der Umstand, dass er nicht mehr „standesgemäß" gekleidet war, drosselte seinen Drang, in unangemessenen Situationen Musik zu komponieren.

Außerdem trug ich keine Machtkämpfe mehr mit meinem Sohn aus. Anstatt ihn mühsam davon zu überzeugen, bei Temperaturen von 30 Grad keine langen Hosen und langärmeligen T-Shirts zu tragen, ließ ich ihn einfach selbst herausfinden, was man an heißen Sommertagen am besten anzieht. Ein paarmal packte ich ihm ein T-Shirt und Shorts in den Rucksack und erklärte ihm, dass er sich umziehen könne, wenn es ihm zu warm wurde. Irgendwann zog er sich tatsächlich um. Wenn er wütend wurde, sagten die Erzieherin und ich zu ihm: „Ich verstehe, warum du dich so fühlst" oder: „Es muss frustrierend sein (...)", um ihm zu zeigen, dass wir ihn verstanden; auf diese Weise ließ er sich leichter zur Kooperation bewegen. Die Erzieherin forderte Dave auf, mehr Verantwortung für sein Verhaltensdiagramm zu übernehmen. Von da an konnte Dave selbst entscheiden, ob er einen Belohnungsaufkleber für sein Verhalten verdient hatte

oder nicht. Ihm selbst d
wirksame Methode, die i
In den letzten Woche
tensdiagramm nicht me
Probe, aber als die Erzie
tensdiagramm jederzeit
Beurteilung am Ende de
„Muss besser werden" b
haltensweisen kontrollie
nächsten Schuljahr darf

Pädagogen und medizin
schließlich wurden sie
delt werden können. Ins
Probleme zu definieren
schen Störungen im DSM

Eine Diagnose dient
mit wenigen Worten sel
troffene weiterzugeben.
Behandlung betrifft, und
Vorstellung davon, was
eine Erleichterung für je
ten Problemen zu kämpf
tens kann eine Diagnose
den zu überwinden – zu
Fördermaßnahmen von
sene eine entsprechende
mehrfach beschrieben ha
sich, vor allem dann, we
zutreffend ist.

Diagnostische Kategor
gebracht – zum einen, um
aber auch, um den sich
gerecht zu werden, die na
mentvollen, widerspenstig
gewicht wird „Adipositas",

Um eine psychische ode
diagnostizieren, genügt es je

oder nicht. Ihm selbst die Verantwortung für sein Handeln zu übertragen, war eine wirksame Methode, die ihm eine größere Kontrolle über sein Verhalten gab.

In den letzten Wochen des Schuljahrs entschied die Erzieherin, dass das Verhaltensdiagramm nicht mehr nötig war. Dave stellte sie zwar noch ein paarmal auf die Probe, aber als die Erzieherin ihn darauf aufmerksam machte, dass sie das Verhaltensdiagramm jederzeit wieder einführen könne, kooperierte er schnell. In seiner Beurteilung am Ende des Schuljahrs gab es keinen einzigen Punkt, der mit einem „Muss besser werden" bewertet wurde! Obwohl Dave nicht alle seine negativen Verhaltensweisen kontrolliert, hat er doch beträchtliche Fortschritte gemacht, und im nächsten Schuljahr darf er wieder in seinen Kindergarten kommen.

Pädagogen und medizinisch-therapeutische Fachleute verleihen ständig Etiketten – schließlich wurden sie dazu ausgebildet, Probleme zu benennen, damit sie behandelt werden können. Insbesondere Psychologen und Psychiater sind darin geschult, Probleme zu definieren, um sie dann einer der fein säuberlich geordneten psychischen Störungen im DSM-5 oder in der ICD-10 zuzuordnen.

Eine Diagnose dient einem vierfachen Zweck: Erstens gestattet sie Fachleuten, mit wenigen Worten sehr viele Informationen an Kollegen, Lehrer, Eltern und Betroffene weiterzugeben. Zweitens ist die Diagnose meist richtungsweisend, was die Behandlung betrifft, und sie geht oft mit einer Prognose einher und vermittelt eine Vorstellung davon, was in Zukunft geschehen wird. Drittens kann eine Diagnose eine Erleichterung für jemanden sein, der an einer Störung leidet und mit bestimmten Problemen zu kämpfen hat, denn sie bestätigt seine Schwierigkeiten. Und viertens kann eine Diagnose erforderlich sein, wenn es darum geht, bürokratische Hürden zu überwinden – zum Beispiel Leistungen von der Krankenversicherung oder Fördermaßnahmen von der Schule zu erwirken –, damit das Kind oder der Erwachsene eine entsprechende Unterstützung erhält. Wie wir jedoch in diesem Buch mehrfach beschrieben haben, bringen Diagnosen auch ein potenzielles Risiko mit sich, vor allem dann, wenn das Etikett, das den Betroffenen verliehen wird, nicht zutreffend ist.

Diagnostische Kategorien und Kriterien werden laufend auf den neuesten Stand gebracht – zum einen, um neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entsprechen, aber auch, um den sich wandelnden sozialen Gegebenheiten und Einstellungen gerecht zu werden, die nach immer neuen Etiketten verlangen. Aus dem temperamentvollen, widerspenstigen Kind wird ein „verhaltensgestörtes" Kind; aus Übergewicht wird „Adipositas", aus Rauchen „Abhängigkeit".

Um eine psychische oder emotionale Störung oder eine Lernstörung korrekt zu diagnostizieren, genügt es jedoch nicht, die Verhaltensweisen, die ein Mensch zeigt,

mit einem Etikett zu versehen. Jede dieser Kategorien hängt vom Kontext ab, weshalb die Umgebungssituation des Betroffenen ebenfalls berücksichtigt werden muss. Der Kontext, in dem ein bestimmtes Verhalten auftritt, bleibt beim diagnostischen Prozess jedoch nur allzu oft außen vor; er wird nicht annähernd so gründlich untersucht wie das Verhalten selbst. Es kann viele verschiedene Gründe geben, warum ein Kind widerspenstig ist oder ein Erwachsener sich in sozialen Situationen nicht wohlfühlt. Solange der Kontext nicht untersucht wird, besteht die Gefahr, dass die Diagnose falsch und die Behandlung unwirksam oder kontraproduktiv ist.

Alle Berufsgruppen müssen die Verfahrensweisen in ihren jeweiligen Spezialgebieten laufend evaluieren, und medizinisch-therapeutische Fachleute sollten ihre Diagnosen ebenso auf Richtigkeit und Nützlichkeit überprüfen. Nur so lässt sich vermeiden, dass die Verhaltensweisen, die typischerweise mit Hochbegabung einhergehen, weiterhin pathologisiert werden. Wenn es angezeigt ist – und in den allermeisten Fällen scheint das der Fall zu sein –, muss die Hochbegabung und ihr Einfluss auf das Verhalten der Person beim diagnostischen Prozess und bei den Behandlungsempfehlungen berücksichtigt werden.

Der diagnostische Prozess

Schon allein der Grund, weshalb jemand bei einer Fachperson vorstellig wird, kann wichtige Informationen und Hinweise liefern. Warum hochbegabte Kinder oder Erwachsene einen Arzt oder Therapeuten aufsuchen, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Möglicherweise haben Familienmitglieder, Lehrer oder Arbeitskollegen den Anstoß gegeben, weil sie den Eindruck haben, dass etwas „nicht stimmt", obwohl sich der Betroffene überhaupt nicht beeinträchtigt fühlt. Diese hochbegabten Personen zeigen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht pathologische Verhaltensweisen, die für Hochbegabte normal sind, von den Menschen im Umfeld der hochbegabten Person aber nicht verstanden werden.

Es kann aber auch sein, dass die Person problematische Verhaltensweisen zeigt, die im Wesentlichen Reaktionen auf eine unpassende Umgebung sind. In der Regel ist das die Schule oder der Arbeitsplatz, mitunter aber auch das häusliche Umfeld. Die Verhaltensweisen können zwar dramatische Formen annehmen, sind aber dennoch normale Reaktionen auf die mangelnde Passung zwischen dem Hochbegabten und seinem Umfeld. Nehmen wir zum Beispiel ein Kind, das sich weigert, in der Schule Routineübungen zu machen, und stattdessen den ganzen Tag seine Lieblingsbücher lesen möchte, oder ein Kind, das sich schlichtweg weigert, zur Schule zu gehen, weil es sich dort langweilt. Andere sehen darin möglicherweise ein oppositionelles Trotzverhalten oder einen Hinweis auf eine andere Verhaltensstörung. Das

kann zu einem weiteren Grund führen, weshalb das hochbegabte Kind an eine Fachperson überwiesen wird.

Der dritte Grund sind Verhaltensweisen, die aus dem langjährigen vergeblichen Bemühen der hochbegabten Person resultieren, den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Das führt irgendwann zu Wut, Depression und anderen psychischen Störungen. In einer solchen Situation könnte eine psychiatrische Diagnose zwar angemessen sein, aber die Wurzeln des Problems liegen in der Umgebung des Betroffenen – etwa in einer ungeeigneten Schule oder dem falschen Arbeitsumfeld – und nicht in der Person selbst. In solchen Fällen besteht die wirksamste „Behandlung" darin, die Probleme mit der Umgebung anzugehen und zu schauen, inwieweit die Person den Erwartungen, die dort an sie gestellt werden, überhaupt gerecht werden kann oder will, und ihm dabei zu helfen, produktive Lösungen zu finden.

Der vierte Grund für eine Überweisung an eine Fachperson ist die asynchrone Entwicklung des Kindes. Beispielsweise könnten die Schlafstörungen eines Kindes auf eine innere Unruhe oder starke Stimmungsschwankungen – möglicherweise sogar auf eine existenzielle Depression – zurückgehen, die es in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Extreme Ausprägungen ganz normaler Phasen wie Bettnässen, Pavor nocturnus oder Tics können ebenfalls den Ausschlag für eine Evaluation geben, da viele dieser Phasen bei normalen Kindern unbemerkt ablaufen. Das hochbegabte Kind, dessen Kopf schneller arbeitet als die Finger, ist unter Umständen frustriert, weil es mit dem Schreiben nicht klappt. Die Frustration kann auch davon herrühren, dass das Kind intellektuell zwar in der Lage ist, bestimmte Leistungen zu erbringen, in seiner körperlichen Entwicklung jedoch hinterherhinkt. Perspektivloses Schwarz-Weiß-Denken kann zu rätselhaftem Verhalten und Phobien führen. Wir wissen, dass es bei manchen hochbegabten Kindern zu extremen emotionalen Reaktionen kommen kann, wenn sie Zeuge von Gewalttaten im Fernsehen werden oder davon ausgehen, dass das Gebot „Du sollst nicht töten" auch für Insekten gelten muss und dann eines anderen belehrt werden. Solche Kinder profitieren von bestimmten Beratungs- oder Therapieformen, etwa einer Ergotherapie, gegebenenfalls auch von einer medikamentösen Behandlung, selbst wenn sie die Kriterien für eine psychiatrische Diagnose nicht wirklich erfüllen (was allerdings nicht heißt, dass die Krankenversicherung nicht für die Kosten aufkommen oder die Schule keine Anpassungen vornehmen muss).

Der fünfte Überweisungsgrund sind Doppeldiagnosen. In solchen Fällen werden Lernstörungen, ADHS, sensorische Integrationsstörungen oder andere Probleme möglicherweise von den herausragenden Fähigkeiten des Kindes überdeckt oder kompensiert. Oder das hochbegabte Kind leidet an einer reaktiven Hypoglykämie oder an einer Allergie. Probleme wie diese werden am besten angegangen, indem man dem Kind Möglichkeiten aufzeigt, wie es seine Stärken einsetzen kann, um seine

sie eine besondere Begabung haben, fallen ihnen so leicht, dass sie sich nur schwer vorstellen können, wie schwierig sie für durchschnittlich begabte Menschen sind. Aus diesem Grund sollte die Fachperson die Entwicklungsgeschichte des Klienten sorgfältig prüfen und sein Entwicklungsniveau identifizieren, um Hinweise auf eine Hochbegabung auszumachen.

Treten die Probleme nur in bestimmten Situationen auf?

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, wie wichtig es ist, festzustellen, ob das Problemverhalten nur in bestimmten Situationen und Umgebungen auftritt. Die meisten diagnostizierbaren Verhaltensstörungen sind nämlich nicht situationsgebunden, und umgekehrt verschwinden die Symptome auch nicht in bestimmten Situationen. Bei hochbegabten Kindern und Erwachsenen sind die Probleme eindeutig situationsabhängig. So werden die problematischen Verhaltensweisen zum Beispiel geringer oder verschwinden ganz, wenn die Person mit anderen Hochbegabten interagiert.

Wenn ein Kind dagegen ADHS hat, zeigt es die entsprechenden Verhaltensweisen nicht nur in ganz bestimmten Situationen, sondern in unterschiedlichen Umgebungen – zu Hause, in der Schule, auf dem Spielplatz, mit den Nachbarskindern oder bei den Pfadfindern. Bei einem hochbegabten Kind treten die Aufmerksamkeitsprobleme dagegen nur in manchen Situationen auf, in anderen nicht. Bemerkenswerterweise sind sie gerade in solchen Situationen, von denen man annehmen würde, dass sie sie hervorrufen, überhaupt nicht vorhanden. Das Problem kann zum Beispiel in der Schule auftreten, aber nicht zu Hause; bei den Pfadfindern, aber nicht beim Fußballtraining; mit Gleichaltrigen, aber nicht mit Erwachsenen. Ein Kind mit Asperger-Störung zeigt das Problemverhalten sowohl zu Hause als auch in der Schule und auf dem Spielplatz, und es bessert sich auch nicht, wenn das Kind mit hochbegabten Kindern oder mit anderen Asperger-Betroffenen zusammen ist. Daher ist es entscheidend, den Kontext zu untersuchen, in dem das Problemverhalten auftritt, und, was noch wichtiger ist: Es muss untersucht werden, ob sich das Verhalten irgendwie verändert, sobald die Person mit anderen Hochbegabten zusammen ist.

Manchmal tritt unangemessenes Verhalten in einer bestimmten Umgebung auch nicht aufgrund dieser Umgebung, sondern aufgrund der Gegebenheiten einer anderen Umgebung auf. Wir kennen zum Beispiel Kinder, die nur in der Schule Probleme hatten, was damit zusammenhing, dass es in der Schule Regeln gab. Zu Hause gab es nämlich keine. Es ist absolut klar, dass die Eltern sich nicht über Verhaltensprobleme beklagten, wenn kein Verhalten ihres Kindes so weit ging, dass sie es für nötig gehalten hätten, ihm gewisse Grenzen zu setzen.

Inwieweit stimmen die Verhaltensweisen mit den diagnostischen Kriterien überein?

Bei den meisten diagnostischen Kategorien gibt es bestimmte Kriterien, was die Art und Häufigkeit eines Verhaltens betrifft. Eine Fachperson kann zwischen Hochbegabung und einer bestimmten Störung unterscheiden, indem sie prüft, inwieweit ein Verhalten mit den Kriterien übereinstimmt, die erfüllt sein müssen, damit die Diagnose gestellt werden kann. Um Fehldiagnosen zu vermeiden, würde es in vielen Fällen schon genügen, einfach die Kriterien mit dem Problemverhalten abzugleichen, welches der Grund für die Überweisung war.

Doppeldiagnosen

In den vorangehenden Kapiteln haben wir bestimmte Störungen identifiziert, die mit Hochbegabung einhergehen können, und bei manchen Diagnosen – zum Beispiel bei der Asperger-Störung oder der existenziellen Depression – sind bestimmte Aspekte der Hochbegabung offenbar sogar ursächlich beteiligt. In solchen Fällen sollte die Hochbegabungskomponente sowohl bei der Aufklärung und Beratung des Patienten als auch bei der Behandlungsplanung berücksichtigt werden. So kann es zum Beispiel ein hochbegabtes Kind beruhigen, wenn es erfährt, dass seine Intensität und Sensitivität – und die damit zusammenhängenden Probleme – nicht auf den diagnostizierten Zustand zurückgehen, sondern mit seiner Hochbegabung zusammenhängen und dass es damit nicht allein ist. Diese Information trägt dazu bei, dass das hochbegabte Kind mithilfe seines scharfen Intellekts begreift, was die Diagnose bedeutet – und auch, was sie nicht bedeutet. Ein hochbegabtes Kind, dem ADHS diagnostiziert wird, ist in der Lage, fortgeschrittene mentale Strategien einzusetzen, die ihm helfen, seine Symptome zu kontrollieren, während das bei einem intellektuell normalbegabten Kind gleichen Alters eher nicht der Fall ist.

In manchen Situationen ist es besonders schwierig, passende Interventionen für eine Doppeldiagnose zu finden. Zum Beispiel scheint in vielen Schulen der Grundsatz „Nur ein Etikett pro Person" zu herrschen – ein Kind kann demnach entweder hochbegabt sein oder eine Lernstörung haben, aber nicht beides zusammen. Aus diesem Grund dürfen die Eltern nur ein spezielles Förderprogramm für ihr Kind wählen – entweder eines für die Hochbegabung oder eines für die Lernstörung. Im Falle einer Doppeldiagnose ist es aber wichtig, die Auswirkungen beider Diagnosen anzugehen und nicht nach dem Entweder-oder-Prinzip zu verfahren.

Unsere Tochter Keesha kam in die erste Klasse einer neuen Schule, die den Ruf hatte, besonders kindzentriert und flexibel zu sein und auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler einzugehen. In der zweiten Schulwoche wurde eine Elternkonferenz einberufen. Als ich das Klassenzimmer betrat, wurde ich in die Bücherecke geführt und sollte auf einem Stuhl in Kindergartengröße Platz nehmen. Ich saß also auf dem winzigen Stuhl, während zwei betagte Pädagogen rechts und links von mir eine Litanei von Beschwerden über Keeshas Verhalten vortrugen. Unter anderem hieß es, sie zeige eine verspielte Impulsivität, folge den Anweisungen der Lehrer nicht, habe Schwierigkeiten, sich auf den Unterricht zu konzentrieren und schleiche sich immer wieder in die Bücherecke, um etwas über die „Bismarck" – ein deutsches Schlachtschiff im Zweiten Weltkrieg – zu lesen.

Die Lehrer betonten zwar, dass Keesha ein freundliches und liebevolles Kind sei, doch ihre ständigen Versuche, die neuen Freunde zu umarmen, und ihr hyperaktiver Bewegungsdrang würden soziale und schulische Probleme nach sich ziehen, die sich sicherlich negativ auf ihre Unterrichtserfahrung auswirkten. Was sie dann sagten, traf mich wie ein Schlag: „Ihre Tochter braucht fachmännische Hilfe." Ich merkte, wie Wut auf die Lehrer in mir hochstieg, doch der eigentlich schlimme Gedanke war, dass etwas mit meiner Tochter nicht stimmte.

Der Psychologe, der Keesha daraufhin testete, war ganz aufgeregt, nachdem er die Ergebnisse ausgewertet hatte: Das sei der zweithöchste IQ-Wert, der ihm in dreißig Jahren Praxis begegnet sei. Er beruhigte meinen Mann und mich und meinte, es würden spannende Zeiten auf uns zukommen. Wir fühlten uns ermutigt und stellten Recherchen an, was wir als Nächstes unternehmen sollten.

Der schriftliche Evaluationsbericht, den der Psychologe an die Schule weitergab, schien die Lehrer zunächst zu beschwichtigen, doch Keesha war weiterhin impulsiv und konnte sich im Unterricht nicht gut konzentrieren. Man zog die eine oder andere Anpassung in Betracht, doch obwohl Keesha nun nicht mehr so sehr als „Problemkind" galt, war nicht zu übersehen, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich der schulischen Umgebung anzupassen; mehr noch, sie zeigte dieselben Symptome auch in anderen Situationen. Wieder wurden Tests durchgeführt und Berichte geschrieben, aber diesmal lautete die Diagnose: ADHS. Nur ungern stimmten wir der Behandlung mit Ritalin® zu, aber die Alternative – schlechte soziale Beziehungen und negative Schulerfahrungen – erschien uns noch schlimmer.

Zwei Jahre später ließ sich die Schule schließlich davon überzeugen, einige Änderungen im Unterrichtsprogramm vorzunehmen, um Keeshas Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Die Medikamente wirken gut, und unsere Tochter meint, sie würden ihr helfen, klarer zu denken und sich besser zu kontrollieren. Hin und wieder tauchen noch ein paar Wolken am Horizont auf, aber insgesamt scheint bei uns wieder die Sonne.

Wie stark ist die Beeinträchtigung?

Der Satz „Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen" erscheint bei fast allen diagnostischen Kriterien im DSM-5 und in der ICD-10. Unserer Erfahrung nach wird das Ausmaß der Beeinträchtigung in den diagnostischen Erwägungen der Kliniker aber leider nicht immer berücksichtigt. In den meisten Fällen genügt es nicht, dass die Person die Verhaltensweisen zeigt, die mit einer bestimmten Diagnose assoziiert sind; die Verhaltensweisen müssen auch in mindestens einem Funktionsbereich Beeinträchtigungen verursachen.

Wie wir in diesem Buch gezeigt haben, können bei hochbegabten Kindern und Erwachsenen genau jene Verhaltensweisen, die Teil ihrer Hochbegabung sind, den Symptomen einer bestimmten Diagnose ähneln. Wenn die Verhaltensweisen zu diesem Zeitpunkt jedoch keine signifikante Dysfunktion verursachen, ist der Kliniker unseres Erachtens besser beraten, der hochbegabten Person (und den Eltern) zu erklären, warum sie bestimmte Verhaltensmuster zeigt und welche Probleme daraus in Zukunft entstehen könnten, und ihr vorbeugend Tipps zu geben, anstatt eine unnötige Behandlung in die Wege zu leiten. Vielleicht braucht es nicht mehr als eine konkrete Erklärung der Verhaltensweisen und ein paar einfache Maßnahmen.

Den besonderen Intellekt des hochbegabten Klienten bei Gesprächen berücksichtigen

Unabhängig davon, ob und welche Diagnose einem hochbegabten Kind oder Erwachsenen gestellt wird, sollte die Fachperson unbedingt auf den herausragenden Intellekt des Klienten Rücksicht nehmen. Die meisten hochbegabten Klienten stellen auf eigene Faust ausgiebige Nachforschungen an und recherchieren im Internet, lesen Bücher oder Fachartikel über Hochbegabung und wissen genau, ob ihre Verhaltensweisen für sie selbst oder andere irgendein Problem darstellen. In der Regel stellen sie der Fachperson sehr viele Fragen. Es empfiehlt sich daher, etwas mehr Zeit einzuplanen, um diese Fragen zu beantworten. Auf diese Weise lässt sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient aufbauen. Wenn man die Neugier und den Wunsch nach tieferem Wissen einfach ignoriert, erreicht man damit womöglich das Gegenteil.